TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐẾN TẦN SUẤT SỬ DỤNG VÀ CHI PHÍ TIỀN TÚI (OOP) CHO DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ GIỮA NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ



Presented By:

Nhóm 2

Nội dung:

Chương 9

THÀNH VIÊN



- Trương Nhật Duy
- Trần Phương Minh
- Phạm Thị Thảo Nguyên
- Trần Ngọc Quân

NỘI DUNG

1 Tổng quan

2 Cơ sở lý thuyết

3 Thực trạng ở Việt Nam

4 So sánh với thế giới

5 Kết luận và hàm ý chính sách







MÔ TẢ VẤN ĐỀ

- Mặc dù tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế (BHYT) đã tăng mạnh (đạt khoảng 94% năm 2024), hiệu quả bảo vệ tài chính của nó vẫn còn gây tranh cãi. Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng chi phí tiền túi (OOP) cao, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế, dẫn đến nguy cơ chi tiêu thảm họa cho hộ gia đình *(Lee et al. (2019))*.
- Người dân có xu hướng vượt tuyến, tập trung vào các bệnh viện tuyến trên, gây quá tải và tăng chi phí.
- Bằng chứng thực nghiệm cho thấy cư dân nông thôn có tần suất sử dụng dịch vụ ngoại trú thấp hơn khoảng 3 lần và xác suất đi khám thấp hơn 4,9% so với cư dân thành thị (*Doan, T. T. N., & Giang, L. T. (2025)*).
- Rủi ro đạo đức và lựa chọn ngược

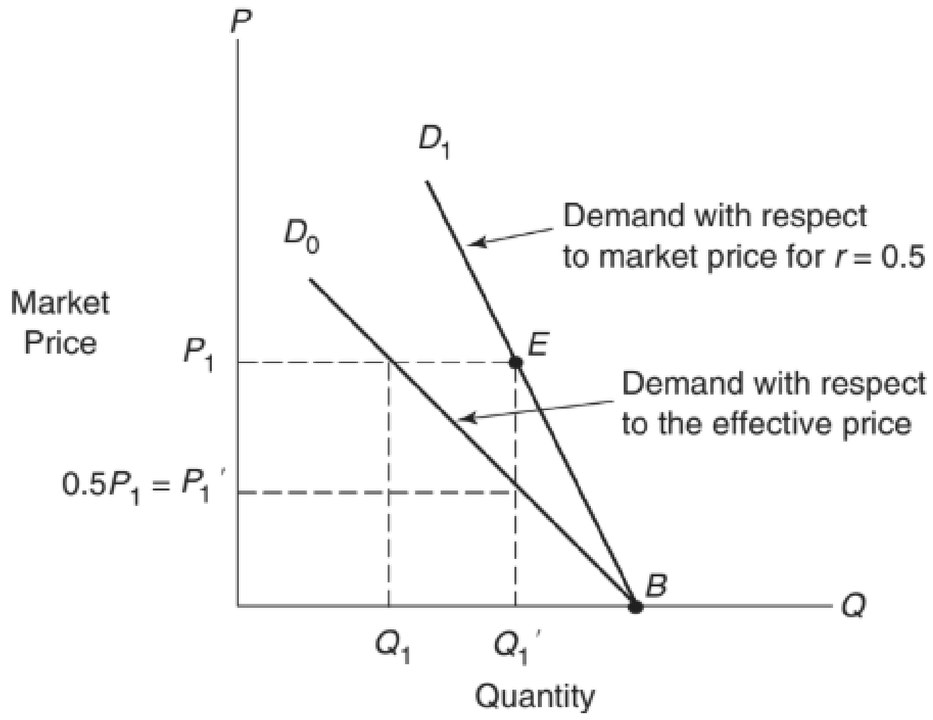
CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Theo lý thuyết cầu của Folland et al. (2013):

- Không có BHYT: Tại mức giá thị trường P1 (OOP) → tiêu thụ số lượng dịch vụ y tế Q1.
- Tham gia BHYT với tỷ lệ đồng chi trả r = a% → giá thực tế phải trả P1' = a% x P1 và tiêu thụ một lượng mới là Q1'. Hay nói cách, giờ đây, ở mức giá thị trường P1, người tiêu dùng đã tăng số lượng dịch vụ y tế sử dụng lên đến Q1'.

=> BHYT đã làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với dịch vụ y tế.

Ngoài ra, khu vực sống (nông thôn/thành thị) cũng được nhận định là một trong các yếu tố có tác động đến cầu dịch vụ y tế (Folland et al., 2013) → Ảnh hưởng đến mức độ hiệu quả của BHYT đối với cầu giữa hai nhóm.



Nguồn: 1. Folland, S., Goodman, A. C., & Stano, M. (2013). The economics of health and health care (7th ed.). Pearson.

2. Erlyana, E., Damrongplasit, K. K., & Melnick, G. (2011a). Expanding health insurance to increase health care utilization: Will it have different effects in rural vs. urban areas? Health Policy, 100(2–3), 273–281. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2010.11.008

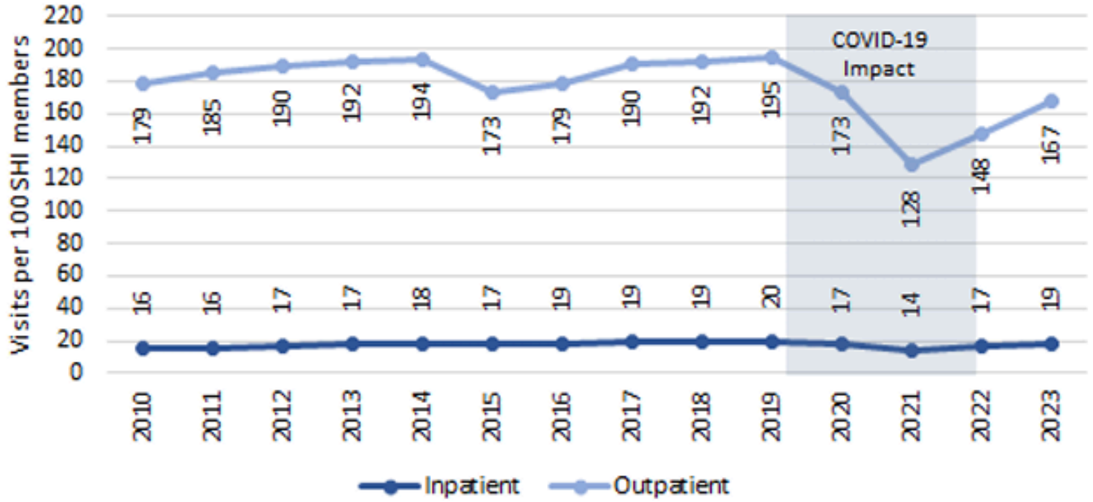
THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Tác động của BHYT đến nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế

Nhìn chung, nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc điều trị của nhóm có BHYT ở cả khu vực nội trú và ngoại trú đều có xu hướng tăng nhẹ qua các năm

Nguồn: Bales, S., & Đào, L. H. (2023). Trends and differentials in household out-of-pocket spending for health in Viet Nam, 2010–2022 (Health, Nutrition, and Population Discussion Paper). World Bank. https://documents.worldbank.org/

Figure 3: Trends in Health Service Utilization Rates, Viet Nam Social Security Data, 2010–23



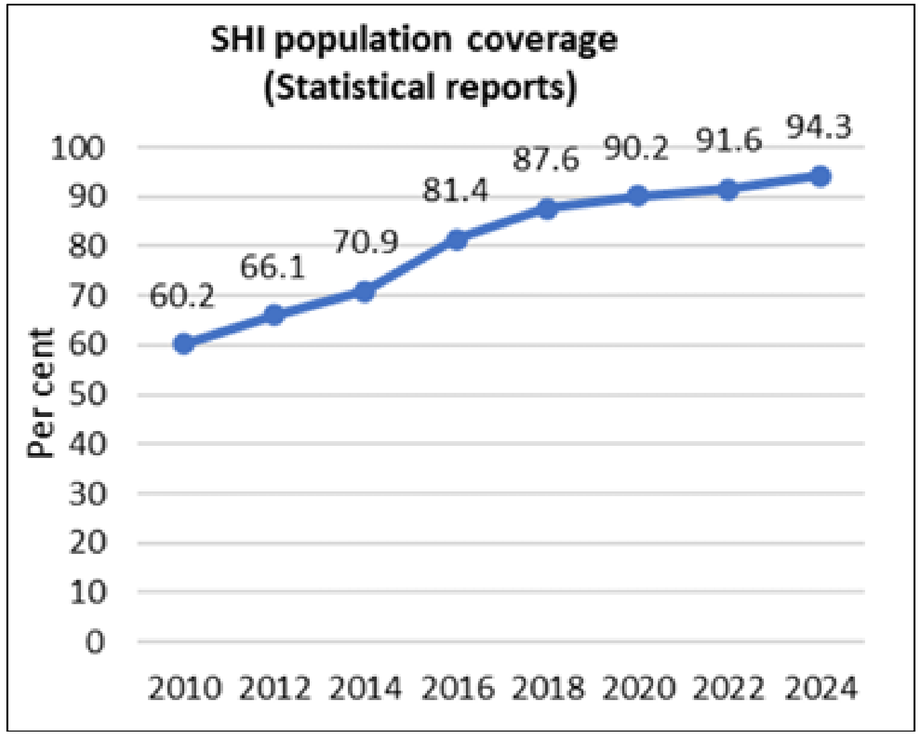
Outcome variable (in last 12 months)	Matching algorithm	VHI subsample		Heavily subsidised subsample	
		ATT	95% CI	ATT	95% CI
No of outpatient visits	NN	0.991*** (0.214)	0.629 to 1.639	1.289*** (0.266)	0.715 to 1.410
	Kernel	1.199*** (0.193)	0.843 to 1561	1.179*** (0.197)	0.830 to 1.704
	Radius	1.177*** (0.190)	0.750 to 1.629	1.173*** (0.196)	0.855 to 1.363
No of inpatient visits	NN	0.127*** (0.034)	0.035 to 0.269	0.156*** (0.058)	−0.014 to 0.271
	Kernel	0.107*** (0.037)	0.019 to 0.171	0.082* (0.045)	0.011 to 0.259
	Radius	0.106*** (0.036)	0.756 to 0.188	0.083* (0.044)	0.087 to 0.226

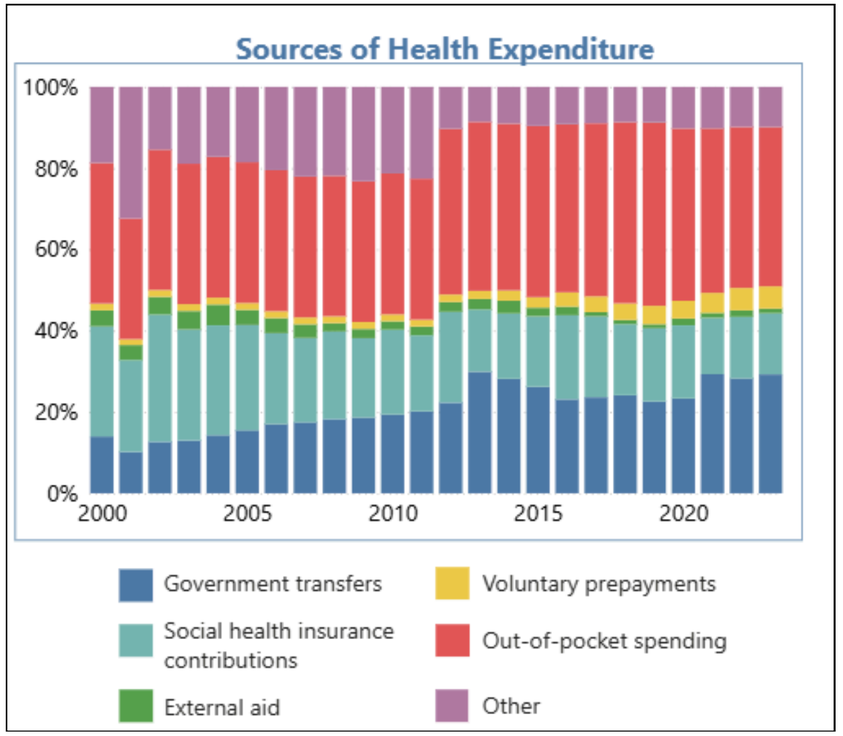
Dựa trên dữ liệu VHLSS 2014 và 2016, Thuong (2020) đã kết luận rằng BHYT làm tăng tuần suất sử dụng dịch vụ y tế ở cả khu vực nội trú và ngoại trú của cả hai nhóm (nhóm VHI và nhóm heavily subsidised). Trong đó, phần lớn đối tượng thuộc nhóm heavily subsidised đến từ khu vực nông thôn (85.2%).

Nguồn: Thuong, N. T. (2020). Impact of health insurance on Healthcare Utilisation Patterns in Vietnam: A survey-based analysis with propensity score matching method. BMJ Open, 10(10). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040062

THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế





Nguồn: Bales, S., & Đào, L. H. (2023). Trends and differentials in household out-of-pocket spending for health in Viet Nam, 2010–2022 (Health, Nutrition, and Population Discussion Paper). World Bank. https://documents.worldbank.org/

Nguồn: World Health Organization. (n.d.). Global Health Expenditure Database: Country health expenditure profiles. Retrieved January 23, 2026, from https://apps.who.int/nha/database/country_profile/Index/en?

Mặc dù tỷ lệ bao phủ BHYT xã hội đã đạt mức cao (chiếm 94.3% dân số năm 2024), tuy nhiên tỷ trọng chi tiêu trực tiếp từ tiền túi (OOP) cho y tế vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Tính đến năm 2023, OOP chiếm xấp xỉ 40% tổng chi tiêu y tế.

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế

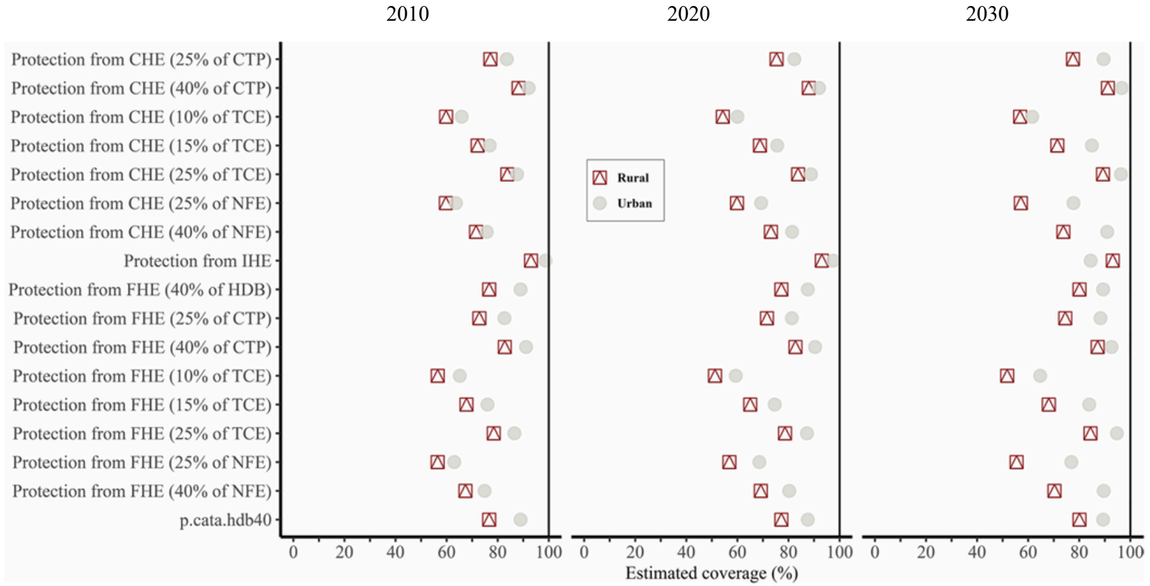


Figure 1. Observations and projections of Financial risk protection indicators in Vietnam by living area

Table 1 National coverage of financial risk protection in Vietnam from 2010–2030, and probability of achieving the 2030 targets

Indicators	Estimated coverage 2010–2020					Predicted coverage to 2030		
	Year 2010 (95% CI)	Year 2016 (95% CI)	Year 2020 (95% CI)	AAPC 2010–2016 (95% CI)	AAPC 2016–2020 (95% CI)	Year 2025 (95% CrI)	Year 2030 (95% CrI)	% reach target
Protection from CHE (25% of CTP)	79.1 (78.2 to 80.0)	75.1 (74.1 to 76.2)	78.1 (77.1 to 79.1)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	0.8 (0.5 to 1)*	81.4 (80.3 to 82.4)	84.3 (82.6 to 85.8)	0.0
Protection from CHE (40% of CTP)	89.4 (88.7 to 90.1)	86.8 (85.9 to 87.5)	89.6 (88.8 to 90.3)	-0.4 (-0.6 to -0.3)*	0.7 (0.5 to 0.9)*	92.2 (91.5 to 92.9)	94.2 (93.3 to 95.1)	4.5
Protection from CHE (10% of TCE)	61.7 (60.5 to 62.8)	56.7 (55.5 to 57.9)	56.6 (55.3 to 57.9)	-0.8 (-1.1 to -0.6)*	0 (-0.3 to 0.2)	58.5 (57.0 to 59.9)	60.8 (58.3 to 63.3)	0.0
Protection from CHE (15% of TCE)	73.6 (72.6 to 74.6)	70.0 (68.9 to 71.1)	71.5 (70.4 to 72.7)	-0.6 (-0.8 to -0.4)*	0.4 (0.1 to 0.6)*	75.0 (73.8 to 76.3)	78.7 (76.7 to 80.5)	0.0
Protection from CHE (25% of TCE)	85.0 (84.1 to 85.7)	82.7 (81.8 to 83.6)	85.8 (85.0 to 86.6)	-0.4 (-0.6 to -0.2)*	0.8 (0.6 to 1)*	89.9 (89.1 to 90.6)	93.2 (92.2 to 94.0)	0.0
Protection from CHE (25% of NFE)	60.9 (59.8 to 62.0)	61.8 (60.6 to 63.0)	63.6 (62.4 to 64.9)	0.2 (-0.1 to 0.4)	0.5 (0.2 to 0.7)*	65.9 (64.5 to 67.3)	68.0 (65.7 to 70.3)	0.0
Protection from CHE (40% of NFE)	72.8 (71.8 to 73.8)	73.3 (72.2 to 74.4)	76.5 (75.4 to 77.5)	0.1 (-0.1 to 0.3)	0.8 (0.5 to 1)*	80.0 (78.9 to 81.1)	83.1 (81.4 to 84.7)	0.0
Protection from IHE	94.8 (94.2 to 95.3)	93.3 (92.6 to 93.9)	94.9 (94.3 to 95.4)	-0.3 (-0.4 to -0.1)*	0.4 (0.3 to 0.5)*	95.4 (94.7 to 96.0)	95.5 (94.4 to 96.5)	83.6
Protection from FHE (40% of HDB)	80.5 (79.5 to 81.4)	77.3 (76.3 to 78.4)	81.4 (80.4 to 82.3)	-0.5 (-0.7 to -0.3)*	1 (0.8 to 1.2)*	84.6 (83.6 to 85.5)	87.0 (85.4 to 88.4)	0.0
Protection from FHE (25% of CTP)	75.8 (74.9 to 76.8)	71.5 (70.4 to 72.6)	75.5 (74.4 to 76.6)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	1 (0.7 to 1.2)*	79.5 (78.3 to 80.5)	82.8 (81.1 to 84.4)	0.0
Protection from FHE (40% of CTP)	85.3 (84.5 to 86.1)	82.0 (81.1 to 83.0)	85.8 (85.0 to 86.7)	-0.6 (-0.7 to -0.4)*	0.9 (0.7 to 1.2)*	89.0 (88.1 to 89.8)	91.3 (90.1 to 92.4)	0.0
Protection from FHE (10% of TCE)	59.2 (58.0 to 60.3)	53.9 (52.7 to 55.1)	54.5 (53.2 to 55.8)	-0.9 (-1.1 to -0.6)*	0.2 (-0.1 to 0.4)	56.8 (55.4 to 58.3)	59.6 (57.1 to 62.0)	0.0
Protection from FHE (15% of TCE)	70.3 (69.3 to 71.4)	66.2 (65.0 to 67.4)	68.9 (67.7 to 70.0)	-0.7 (-0.9 to -0.5)*	0.7 (0.4 to 0.9)*	73.1 (71.8 to 74.3)	77.2 (75.1 to 79.0)	0.0
Protection from FHE (25% of TCE)	80.9 (80.0 to 81.8)	77.9 (76.9 to 78.9)	82.1 (81.2 to 83.0)	-0.5 (-0.7 to -0.3)*	1 (0.8 to 1.3)*	86.8 (85.9 to 87.6)	90.5 (89.3 to 91.6)	0.0
Protection from FHE (25% of NFE)	58.5 (57.4 to 59.6)	58.9 (57.6 to 60.1)	61.6 (60.3 to 62.9)	0.1 (-0.2 to 0.3)	0.7 (0.4 to 1)*	64.7 (63.3 to 66.1)	67.7 (65.3 to 69.9)	0.0
Protection from FHE (40% of NFE)	69.7 (68.6 to 70.7)	69.5 (68.4 to 70.7)	73.6 (72.5 to 74.7)	0 (-0.2 to 0.2)	1 (0.8 to 1.3)*	77.8 (76.6 to 78.9)	81.3 (79.5 to 83.0)	0.0

Nguyen & Le (2025), sử dụng dữ liệu VHLSS các năm 2010, 2016 và 2020, nhận định rằng trong năm 2020, ở cấp độ quốc gia, tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình không rơi và khó khăn tài chính do chi tiêu y tế tương đối cao (dao động từ 78.1% - 94.9%). Đến năm 2030, con số này được dự đoán tăng lên 81.4% – 95.4%. Tuy nhiên, các chỉ số này có sự cách biệt đáng kể giữa khu vực nông thôn và thành thị.

Nguồn: Nguyen, P. T., & Le, P. M. (2025). Progress and inequalities in financial risk protection toward Universal Health Coverage: Insights from Vietnam. International Journal for Equity in Health, 24(1). https://doi.org/10.1186/s12939-025-02659-0

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế



Lee et al. BMC Health Services Research (2019) 19:318
https://doi.org/10.1186/s12913-019-4115-0

BMC Health Services Research

RESEARCH ARTICLE Open Access

Use of high-level health facilities and catastrophic expenditure in Vietnam: can health insurance moderate this relationship?

Hwa-Young Lee[1,2], Juhwan Oh[1*], Hoang Van Minh[3], J. Robin Moon[4] and S. V. Subramanian[5,6]

Abstract

Background: Overcrowding of high-level health facilities is a major concern in a Vietnamese health system. This may increase an economic burden to the households since health insurance is still insufficient in providing financial risk protection. This paper sought to examine the association between the use of high-level health facilities and household-level expenditure status such as out-of-pocket (OOP), and catastrophic expenditure on health, as well as a moderating effect of health insurances in rural and urban districts of Vietnam.

Methods: Data utilized a health system community survey collected between 2015 and 2017 in two districts of Vietnam (one from rural area in northern part, and the other one from urban area in sourthern part). The world Health Organization's definition of catastrophic expenditure was used. Multivariate tobit and logistic regression were employed for catastrophic expenditure and OOP respectively. Interaction term between health insurance status and visit frequency in high-level facilities was included to investigate the moderating effect of health insurance.

Nghiên cứu của Lee et al. (2019), sử dụng dữ liệu huyện Quốc Oai (nông thôn) năm 2015 và dữ liệu thị xã Thuận An (thành thị) năm 2017, cho thấy, BHYT không có tác động đáng kể đến OOP và CHE ở cả hai khu vực này. Tuy nhiên, ở huyện Quốc Oai, so với những hộ gia đình không tham gia BHYT, những hộ gia đình có ít nhất một người tham gia BHYT sẽ có khả năng phát sinh chi tiêu y tế thảm họa thấp hơn khi sử dụng các cơ sở y tế tuyến trên là 0.68 lần.

Nguồn: Lee, H.-Y., Oh, J., Hoang, V. M., Moon, J. R., & Subramanian, S. V. (2019). Use of high-level health facilities and catastrophic expenditure in Vietnam: Can health insurance moderate this relationship? BMC Health Services Research, 19(1). https://doi.org/10.1186/s12913-019-4115-0



Giang et al.
Health Research Policy and Systems 2022, 20(Suppl 1):112
https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3

Health Research Policy and Systems

RESEARCH Open Access

Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: a cross-sectional survey

Nguyen Hoang Giang*, Nguyen The Vinh, Hoang Thi Phuong, Nguyen Thi Thang and Tran Thi Mai Oanh

Abstract

Background: Population ageing and the associated increase in the healthcare needs of older people are putting pressure on the healthcare system in Viet Nam. The country prioritizes healthcare for older people and has developed financial protection policies to mitigate financial hardship due to out-of-pocket health expenditures (OOPHEs) borne by their households. This study examines the level and determinants of the financial burden of OOPHE among households with people aged ≥ 60 years in Viet Nam.

Methods: A cross-sectional household survey was conducted among a sample of 1536 older people living in 1477 households in three provinces representing the North, Central and South regions of Viet Nam during 2019–2020. The financial outcomes were catastrophic health expenditure (CHE), using WHO's definition, and financial distress due to OOPHE. Multivariate binary logistic regression analysis was employed to determine the factors associated with these outcomes.

Nghiên cứu của (Giang et al., 2022) sử dụng dữ liệu khảo sát hộ gia đình từ năm 2019 - 2020 ở ba tỉnh Yên Bái, Thanh Hoá và Tiền Giang đã kết luận rằng BHYT không có tác động đáng kể đến chi tiêu y tế thảm họa (CHE) hay sự kiện khó khăn tài chính (là tình huống mà hộ gia đình phải vay tiền hay bán tài sản để chi trả cho dịch vụ y tế) ở những hộ gia đình có thành viên từ 60 tuổi trở lên.

Nguồn: Giang, N. H., Vinh, N. T., Phuong, H. T., Thang, N. T., & Oanh, T. T. (2022). Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: A cross-sectional survey. Health Research Policy and Systems, 20(S1). https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3

Tác động của BHYT đến chi tiêu tiền túi (OOP) cho dịch vụ y tế

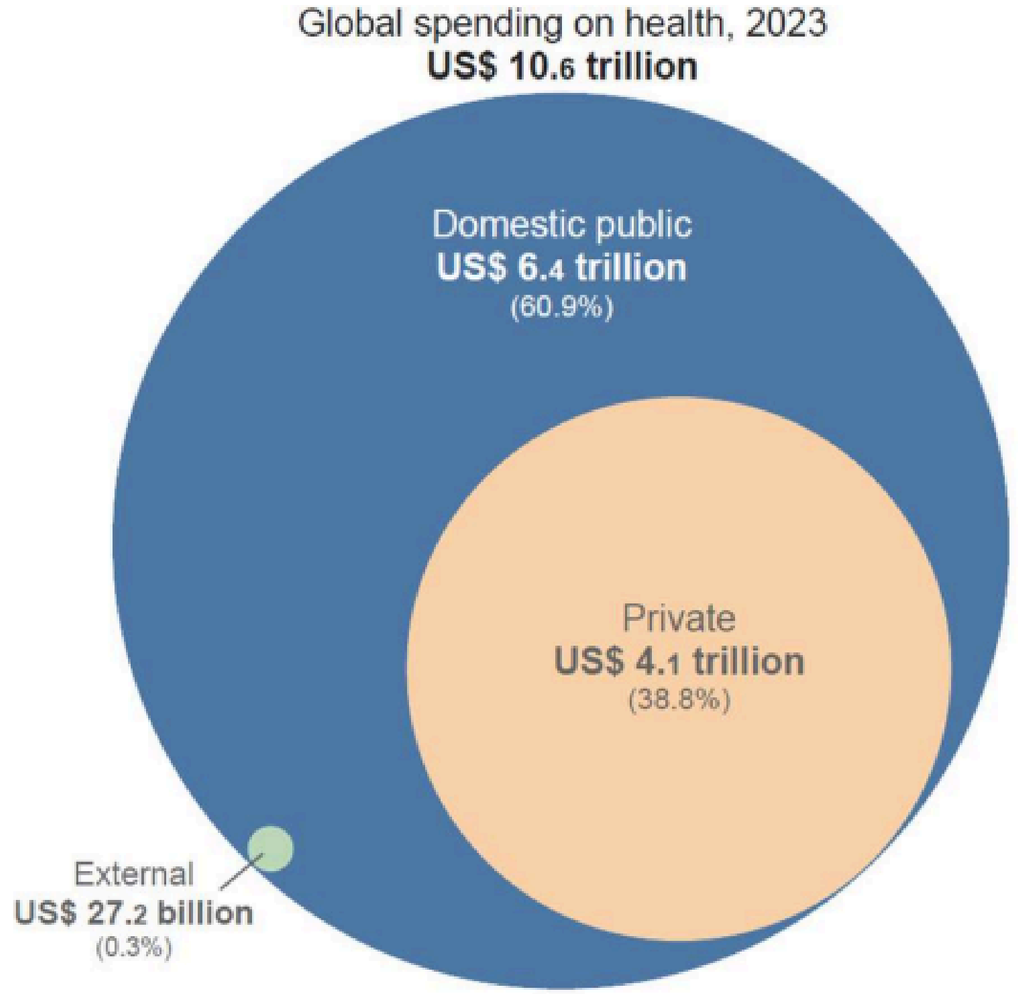
Determinants of catastrophic health expenditure in northern Midlands and mountainous region of Vietnam, 2014 – 2020

Variable	Year/adjusted OR (95% CI)			
The no of household members having health insurance	0.736*** (0.605 to 0.896)	0.778*** (0.643 to 0.941)	0.708*** (0.645 to 0.777)	0.801** (0.646 to 0.994)
	2014	2016	2018	2020

Một nghiên cứu khác của Thuong et al. (2022), dựa trên dữ liệu ở các năm 2014, 2016, 2018 và 2020 ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, kết luận rằng BHYT có vai trò bảo vệ hộ gia đình khỏi chi tiêu y tế thảm họa (CHE). Cụ thể, khi số người trong hộ gia đình có BHYT càng tăng thì khả năng đối mặt với tình huống chi tiêu y tế thảm họa (CHE) sẽ càng giảm.

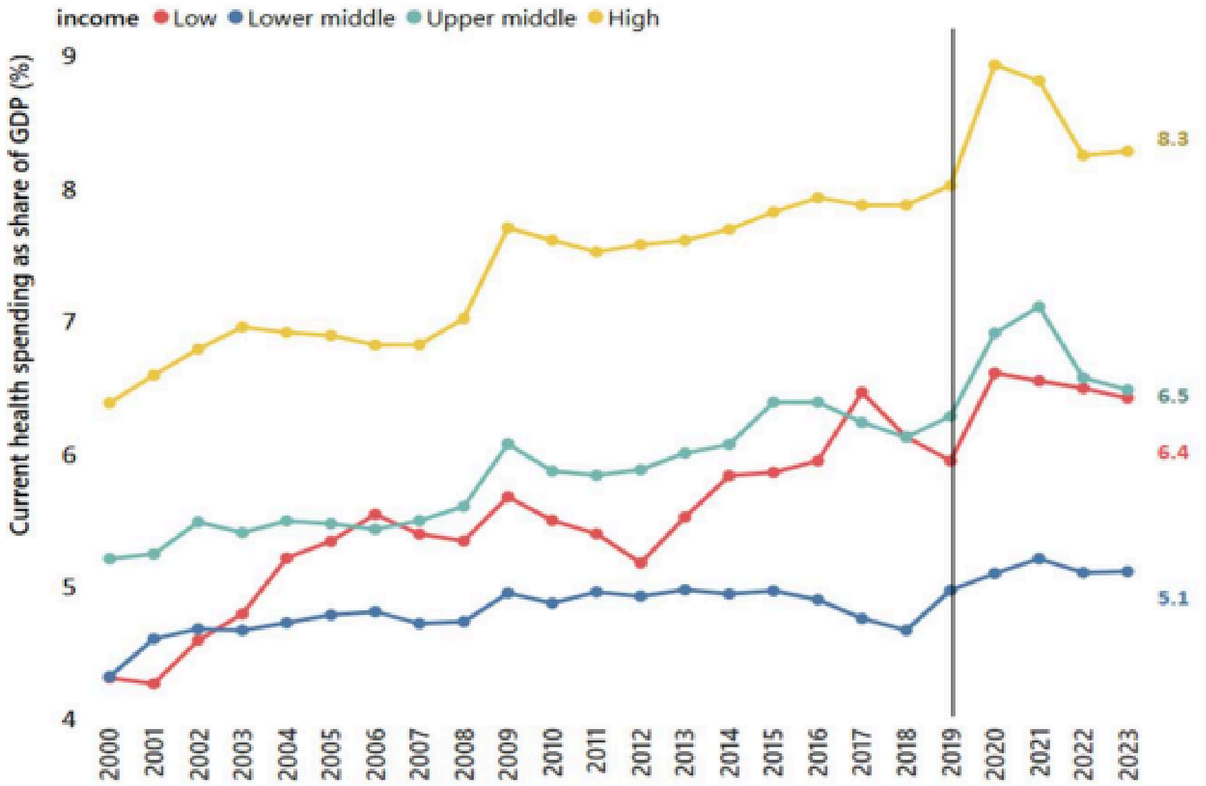
Nguồn: Thuong, N. T., Huy, T. Q., & Huy, D. N. (2022). Catastrophic health expenditure in the northern Midlands and mountainous areas and its determinants, Vietnam from 2014 to 2020: A cross-sectional study. BMJ Open, 12(9). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058849

- Tổng chi tiêu toàn cầu cho y tế đã đạt 10,6 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023.
- Con số này chiếm 10% tổng GDP toàn cầu.



Data source: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

Chi tiêu cho y tế tính theo tỷ lệ phần trăm GDP



Nguồn: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

Các nước thu nhập cao luôn có tỷ trọng chi y tế trong GDP lớn nhất, trong khi các nước thu nhập thấp và trung bình thấp duy trì mức chi thấp hơn, cho thấy khoảng cách rõ rệt về năng lực tài chính cho y tế giữa các nhóm thu nhập.

Health Expenditure Profile

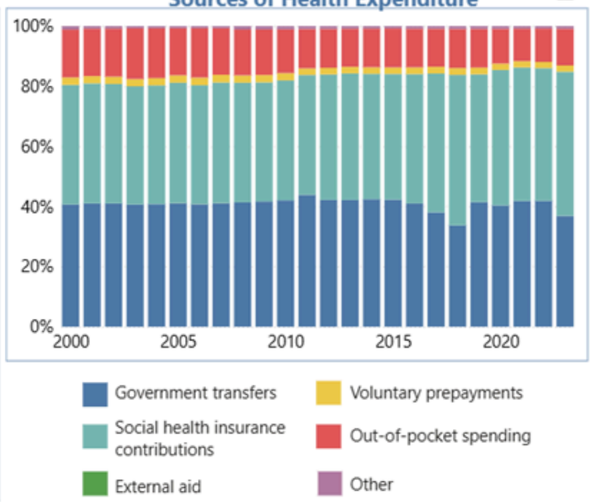
Japan

Select Country / territory: Japan

Key Statistics

	2005	2010	2015	2019	2023
Health spending US$ per capita (CHE)	2.893	4.072	3.754	4.431	3.638
Government domestic health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	81,2%	81,9%	84,1%	84,0%	84,8%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	15,7%	14,6%	12,9%	12,9%	12,2%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	17,8%	18,9%	23,2%	24,7%	23,3%
GDP US$ per capita	37.771	44.928	34.924	40.395	33.876

Sources of Health Expenditure



Thu nhập cao

- Nhật Bản: Chi tiêu y tế cao, tài trợ chủ yếu từ ngân sách và bảo hiểm → gánh nặng chi trả trực tiếp thấp.

Health Expenditure Profile

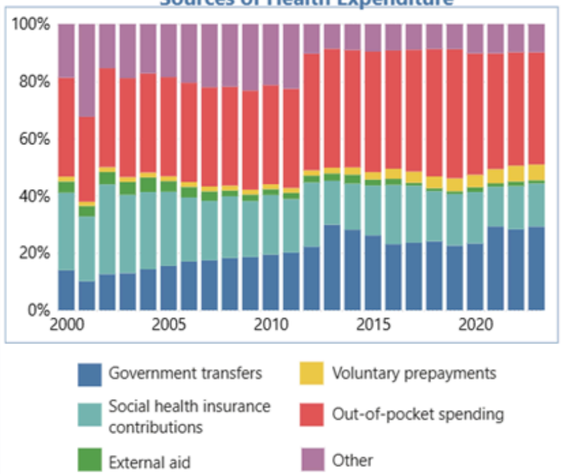
Viet Nam

Select Country / territory: Viet Nam

Key Statistics

	2005	2010	2015	2019	2023
Health spending US$ per capita (CHE)	39	85	121	171	197
Government domestic health spending % Health spending (GGHE-D%CHE)	41,4%	40,3%	43,6%	40,6%	44,3%
Out-of-pocket spending % Health spending (OOPS%CHE)	34,6%	34,7%	42,1%	45,1%	39,2%
Priority to health (GGHE-D%GGE)	8,7%	8,6%	8,5%	10,2%	10,5%
GDP US$ per capita	902	1.683	2.578	3.441	4.323

Sources of Health Expenditure



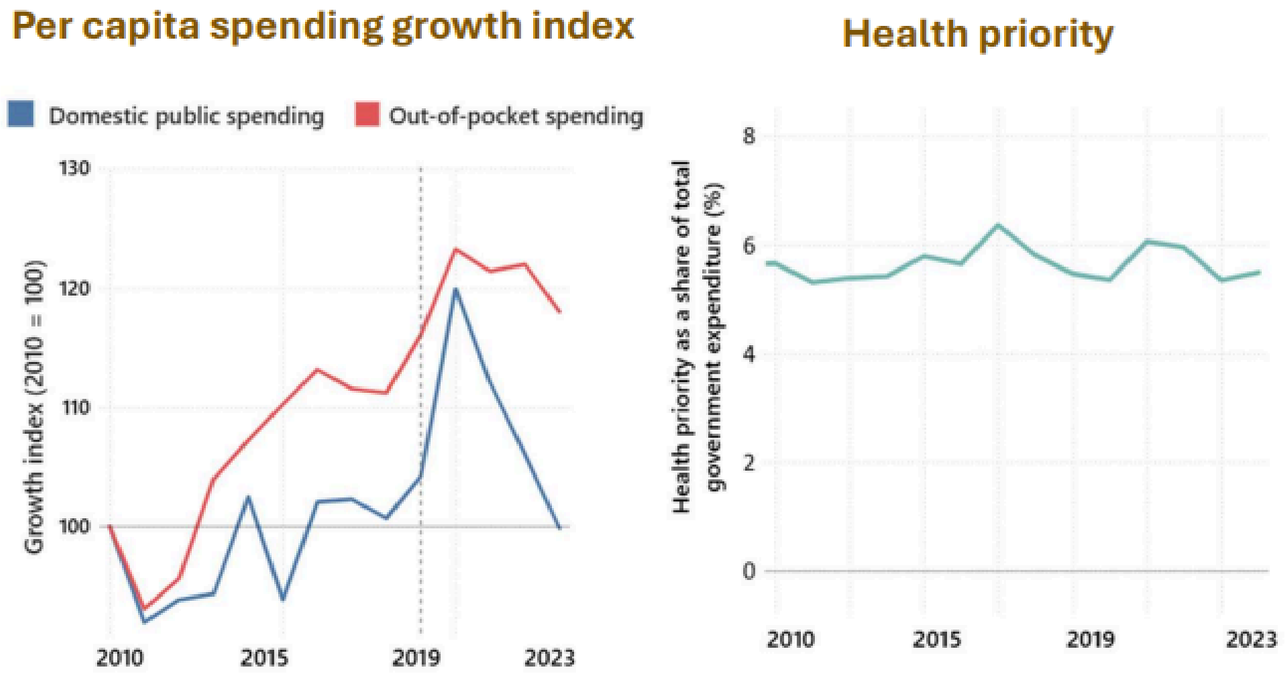
Thu nhập trung bình

- Việt Nam: Chi tiêu y tế thấp hơn, phụ thuộc nhiều vào chi trả trực tiếp → bảo vệ tài chính cho người dân còn hạn chế.

Chi tiêu y tế ở các nước thu nhập thấp tăng chủ yếu do người dân tự chi trả, trong khi tỷ trọng chi ngân sách cho y tế hầu như không đổi.

→ Phản ánh mức độ ưu tiên cho y tế vẫn còn hạn chế.

Health spending trend in low income countries



Data source: WHO Global Health Expenditure Database, 2025

KẾT LUẬN

1. **BHYT có làm tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế ở cả khu vực ngoại trú và nội trú** (Thuong, N. T., 2020)**, nhưng chưa thực hiện tốt vai trò bảo vệ tài chính** (Lee et al., 2019; Giang et al., 2022; Nguyen & Le, 2025).
2. **So với thành thị, người dân sống ở khu vực nông thôn vẫn đối mặt với chi tiêu tiền túi cho dịch vụ y tế cao hơn** (Thuong, N. T., 2020; Nguyen & Le, 2025)

TẠI SAO VIỆT NAM CÓ OOP CAO?

1. Cấu trúc tài trợ y tế khác biệt

Tại Nhật Bản, chi tiêu y tế được tài trợ chủ yếu từ ngân sách Nhà nước và BHYT (chiếm 84.8% năm 2023) → OOP thấp (12.2%)

Tại Việt Nam, nguồn lực công còn hạn chế (chỉ chiếm 44.3% năm 2023) → OOP cao (39.2%) (World Health Organization)

2. Tình trạng vượt tuyến

Lee et al. (2019) tìm thấy có mối liên hệ giữa tần suất khám/chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến trên với việc xảy ra chi tiêu y tế thảm họa cũng như mức chi tiêu tiền túi → Nguyên nhân là vì người dân có xu hướng bỏ qua các trạm y tế địa phương (cấp cơ bản) để trực tiếp tiếp cận các bệnh viện tuyến trung ương → BHYT không còn hiệu lực.

3. Hiệu quả bảo vệ tài chính của BHYT còn hạn chế

Nhiều loại thuốc và vật tư y tế thiết yếu cho bệnh mãn tính vẫn chưa được danh mục BHYT chi trả đầy đủ, khiến người dân, đặc biệt là ở nông thôn, phải chi trả rất nhiều cho tự điều trị (self-treatment) (Lee et al., 2019; Doan & Giang, 2025)

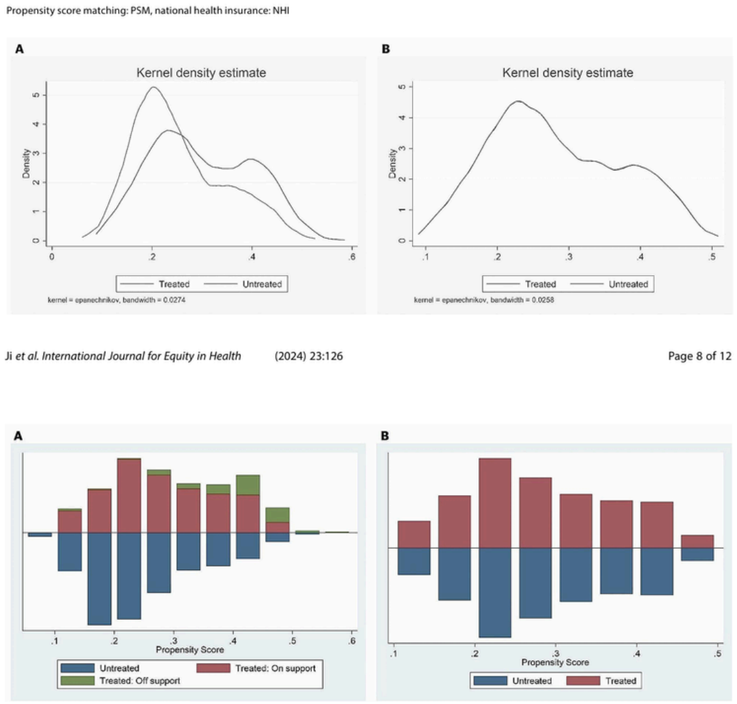
HÀM Ý CHÍNH SÁCH

1. **Chuyển dịch danh mục:**
Thay vì chỉ tập trung tăng số người có thẻ về độ phủ, Việt Nam cần tập trung vào độ sâu như đưa các loại thuốc và dịch vụ kỹ thuật cao từ nhóm người dân tự trả sang nhóm "BHYT chi trả" (giống cách Hàn Quốc đưa 11.96 xuống 11.53)
2. **Thiết lập trần chi phí:**
Học tập mô hình đặt ra mức chi trả tối đa cho hộ gia đình. Khi chi phí vượt ngưỡng, bảo hiểm sẽ chi trả phần còn lại để đảm bảo không ai bị nghèo hóa vì y tế(Nhật Bản)
Chương trình Bảo hiểm Y tế Quốc gia Đài Loan (NHI) được triển khai vào năm 1995 (Chiang, 1997)
3. **Củng cố y tế cơ sở ở nông thôn:**
Giảm hành vi vượt tuyến để cắt giảm các khoản chi phí tiền túi không đáng có, giúp người dân hưởng lợi từ BHYT ngay tại địa phương
(Lee et al., 2019)

Table 3 Results of comparative analysis of changes in medical expenses

Outcome	Group	*N*	Before policy (2016)	After policy (2018)	Dif-fer-ence
NHI payment	Treatment	312	13.66	13.93	0.27
	Control	312	13.17	13.75	0.58
	Difference		0.49	0.18	-0.31
Non-payment	Treatment	312	11.96	11.53	-0.43
	Control	312	10.95	11.75	0.80
	Difference		1.01	-0.22	-1.23**
OOP	Treatment	312	13.04	13.23	0.19
	Control	312	12.22	12.71	0.49
	Difference		0.82	0.52	-0.3

**$P<0.01$, national health insurance: NHI, out-of-pocket payments: OOP



Ji, S., Lee, M., Choi, M., & Park, S. (2024). The impact of the expanded health insurance coverage policy on healthcare spending: evidence from Korea. International Journal for Equity in Health, 23(1), 126. https://doi.org/10.1186/s12939-024-02206-3

Nghiên cứu cho thấy hiệu quả can thiệp của chính sách theo thời gian thể hiện qua sự giảm thiểu các trường hợp không thanh toán cũng như hiệu quả chi trả cho các dịch vụ y tế được bảo hiểm qua chương trình " Moon care " khảo sát sức khỏe năm 2016 và 2018 tại Hàn Quốc

Thank You



Presented By:

Nhóm 2

Nội dung:

Chương 9